Acta psiquiátrica y psicológica de América latina

J. ROF CARBALLO: Poesía y delincuencia • J. MARIATEGUI: La investigación psiquiátrica en el Perú • S. GAETE: Lenguaje y significado • F. OYARZUN: Neurosis del carácter y personalidad psicopática • J. DALMA: Dos coincidencias en varias doctrinas sobre neurosis • R. H. ETCHEGOYEN, J. GARAY y N. QUIROGA: Imagen del padre en un grupo de alcohólicos • F. ESCARDO: La enseñanza de la psicología.

Escaneado con CamScanner

NOTAS Y NOTICIAS

Coloquio ACTA 1965

Familia y enfermedad mental

El 17 y 18 de julio se llevó a cabo el primer coloquio internacional de ACTA, dedicado este año al tema: "Familia y enfermedad mental". Efectuóse la reunión en una casa-quinta de los alrededores de Buenos Aires, "Villa Raquel", cedida gentilmente por sus dueños, el doctor León Berlin y señora, gracias a los cuales pudo materializarse con holgura todo el programa. Ofició de coordinador, el secretario del coloquio, doctor Isidoro Berenstein, y participaron del mismo, presentando trabajos, comentando éstos e intercambiando opiniones, el profesor Nathan W. Ackerman, de New York; el profesor Renato Castro de la Mata, de Lima; Miss Janet Beavin, de Palo Alto, California; el profesor José Bleger, el profesor Eliseo Verón, el doctor Carlos E. Sluzki y el doctor Guillermo Vidal, de Buenos Aires. Actuaron de intérpretes los doctores Héctor Ferrari y Miguel Matrajt, y de secretaria técnica y de observadora respectivamente, la señorita Silvia Alpersohn y la doctora Antonieta Silva de Castro de la Mata. No hubo público presente.

Inició la reunión el doctor Berenstein con una reseña histórica del tema, y, a través de un caso clínico, planteó los grandes problemas del momento: la interacción familiar y la génesis del trastorno mental, la homeostasis, la definición y registro de observables, el miembro más enfermo.

A continuación leyó el doctor Ackerman dos capítulos de un libro suyo próximo a aparecer: *Family Diagnosis and Treatment*. El doctor Ackerman trata aquí de la necesidad de tomar a la familia como un todo, y de la interacción e interdependencia entre individuo y familia, entre salud mental y salud social. En una descripción impresionista, estudia la familia en crisis y los mecanismos homeodinámicos que ésta pone en marcha para sobrevivir como una unidad. La división familiar suele polarizarse en dos personajes: el sanador y el chivo emisario. Tanto el hombre como su familia enferman por muy diversas razones: fracaso de la complementariedad, reducción de las satisfacciones instintivas, aislamiento de los roles, etc. Pero, en general, pueden perfilarse hasta cuatro grupos de factores etiopatogénicos en el trastorno mental: factores predisponentes, contribuyentes, precipitantes y perpetuadores. Si la enfermedad es grave, el consenso familiar, con respecto al miembro enfermo, es de que éste, como individuo, "no debe ser"; en los casos leves, en cambio, la actitud frente al enfermo se reduce a "no debe ser diferente". El director del Instituto de la Familia, de Nueva York, trasluce, a cada momento, su posición psicoterapéutica, anteponiendo la cura del enfermo a las consideraciones metodológicas de la cuestión.

El doctor Castro expuso una investigación psicosocial de la familia peruana, que hizo en colaboración con María Antonieta de Castro, Alegría Majluf y Luis Estrada. Teniendo en cuenta la actitud del padre con respecto a la familia, cabe distinguir tres tipos principales de familias peruanas: el despótico, el patriarcal y el compañero. La familia de tipo despótico es propia de los indios, el tipo patriarcal aparece ya en las familias de obreros y el tipo compañero se destaca exclusivamente en las familias de empleados. La inhabilitación física del padre puso en evidencia los roles básicos de los miembros, su grado de complementariedad y el funcionamiento general de la familia. Los padres despóticos que no cambian de actitud son excluidos, pero en la medida en que pueden cambiar, son aceptados y el funcionamiento de la familia es mejor que antes de la inhabilitación. El rol

Escaneado con CamScanner

Recepción de los invitados extranjeros en el Instituto Grondona

básico del padre es el de proveedor, y cuando éste desaparece como tal, su reacción fue deprimirse.

Carlos E. Sluzki y Janet Beavin presentaron una definición operacional y una tipología de díadas fundadas en el concepto interaccional de simetría y complementariedad. Este trabajo aparecerá publicado en el prórimo número de ACTA.

El doctor Bleger ahonda el tema de la familia por el lado de la simbiosis. Para Bleger habría una simbiosis fundamental y normal, que contendría la parte psicótica de la personalidad de todos los integrantes del grupo. Este reservorio de los niveles más inmaduros y regresivos de la personalidad respaldaría la actividad sana de cada miembro en el extragrupo. La observación clínica muestra en este sentido dos familias extremas: la familia aglutinada y la esquizoide o dispersa. En la primera privaría la organización narcisística; la identidad es grupal, no individual. En la segunda, en cambio, los miembros se apartan unos de otros para evitar el peligro de la fusión y la consiguiente pérdida de identidad. Bleger hace un distingo entre simbiosis normal, simbiosis patológica y autismo, y termina su trabajo diciendo que la simbiosis y el autismo son tanto etapas de la dinámica familiar como estados transitorios y estereotipias patológicas.

Por fin, el Dr. Vidal replantea el tema desde el punto de vista de la individuación. El proceso de realización del sí-mismo —lo que desde Jung se llama individuación— ocurre dentro del ámbito familiar. El nuevo miembro se diferencia progresivamente a partir de una situación indistinta original, y es tanto más sano cuanto mejor pueda metabolizar las contradicciones con que se topa en su devenir relacional. A su vez, esta capacidad de integrarse en el espacio-tiempo de la propia existencia, depende tanto del desprendimiento familiar como de las exigencias del extragrupo. En este sentido, el trastorno mental aparece como una discrepancia, una contradicción no superada entre el grado de individuación con respecto a la familia y el que le reclama individualmente la sociedad global. Por eso toda psicoterapia debe tener en cuenta la familia del enfermo, y ha de apuntar mayéuticamente, a que éste sea reparado y reparido por el médico.

Múltiples y muy fecundos fueron los comentarios y opiniones vertidos en estos dos días de trabajo intensivo. Prácticamente no hubo punto que no haya sido tocado, desde las consideraciones más teóricas en relación con la génesis del trastorno mental, hasta la definición de variables y su registro, con miras a un tratamiento más científico del problema. En más de una ocasión se discutió la validez del método clínico. Quizá por esta

Escaneado con CamScanner

vía se puedan formular hipótesis, mas no resulta fácil verificarlas. De cualquier modo, la visión del psicoterapeuta de familias enfermas todavía parece muy distante de la del metodólogo, y viceversa. El mismo fenómeno, la interacción social, por ejemplo, se nos ofrece bajo aspectos con frecuencia inasibles unívocamente. Necesitamos de las hipótesis y necesitamos al mismo tiempo de la investigación rigurosa. La operación psicoterapéutica no debe ser óbice para que busquemos observables e indicadores independientes. La familia como sistema, el concepto de homeostasis y sus relaciones con la adaptación, la primacía de lo general sobre lo individual en materia de causalidad del trastorno mental, la conveniencia de investigaciones regionales y de pergeñar cuanto antes nuevas técnicas de observación y una tipología de la familia como totalidad, fueron objeto de variadas consideraciones. Una cosa parece clara después de este coloquio, y es que así como hay ya una experiencia vasta sobre psicoterapia del grupo familiar, es muy poco lo que por ahora sabemos objetivamente acerca de la interacción social. Se impone, pues, una descripción no valorativa de las propiedades más importantes del sistema familiar y una definición de los indicadores que han de llevarnos al conocimiento del mecanismo psicopatológico. Hombre y número, teoría y análisis de datos, proclividad a la divagación filosófica y necesidad de captar en leyes la conducta del hombre para mejorar su condición. He aquí el problema, el gran problema con que nos encontramos nosotros los psiquiatras cuando nos aproximamos a la familia. Vale la pena que sigamos planteándolo desde diferentes perspectivas y con modelos distintos. Pues lo que pasa en el seno de la familia tiene mucho que ver, sin duda, con las génesis del trastorno mental.

• Invitados por ACTA y por la **Liga Argentina de Higiene Mental,** estuvieron en Buenos Aires, entre el 10 y el 20 de julio, los doctores Nathan W. Ackerman y Renato Castro de la Mata. El Dr. Ackerman, profesor de psiquiatría en la Universidad de Columbia, Nueva York, pronunció dos conferencias en la cátedra de psiquiatría de nuestra Facultad de Ciencias Médicas, cuyo tema "psicoterapia de la familia" ilustró con sendas películas. Habló asimismo en la Sociedad Hebraica Argentina, refiriéndose a "la problemática psicosocial de la familia judía", y en la Facultad de Filosofía y Letras.

Por su parte, el Dr. Castro, profesor asociado de psiquiatría en la Universidad de San Marcos, Lima, se ocupó de describir "una tipología de la familia peruana" en el Instituto Grondona y en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires.

Declarados huéspedes oficiales por el Instituto Nacional de Salud Mental, participaron, además, en el Primer Seminario Internacional de Salud Mental en la Comunidad.

II Congreso Argentino de psicología

Se realizará en San Luis, entre los días 6 y 13 de noviembre, organizado por la Facultad de Ciencias. El programa comprende un tema central: "Estado actual de la psicología en la Argentina" y tres temas: a) "Aspectos teóricos de la psicología"; b) "Aspectos metodológicos de la psicología"; y c) "Las áreas de aplicación de la psicología". Funcionarán también tres mesas redondas, con relatores previamente designados, sobre: 1) Áreas y tareas de la psicología educacional. 2) Los problemas de técnica en diferentes direcciones psicoterapéuticas. 3) La medida en psicología como orientación matemática en las ciencias del hombre.

Las comunicaciones al congreso deberán ser enviadas antes del 15 de octubre de 1965. Si acaso ello no fuera posible, los autores comunicarán a la brevedad, y antes del 30 de septiembre, el tema de sus trabajos, adjuntando un resumen de 15-20 líneas sobre el mismo. Los trabajos no superarán las 5 ó 6 páginas tamaño oficio, escritas a doble espacio, de manera que su lectura sea posible en 15 minutos. Todo trabajo —cualquiera sea su extensión— será enviado por duplicado y con el resumen correspondiente. Los relatos de mesa redonda serán solicitados directamente por la comisión organizadora y su extensión no excederá las 12 páginas. Para cualquier otra información, dirigirse al Prof. Plácido A. Horas, decano de la Facultad de Ciencias, San Luis.

Quinto Congreso Nacional de Psiquiatría en Colombia

• Se llevará a cabo en Barranquilla del 23 al 27 de noviembre de 1965. Además de los temas libres, habrá tres ponencias oficiales: Angustia, Nomenclatura Psiquiátrica y Legislación Psiquiátrica. Para mayor información dirigirse al secretario general del comité organizador: Dr. Antonio Reales Orozco, calle 70 nº 52-100, Barranquilla, Colombia.

Escaneado con CamScanner